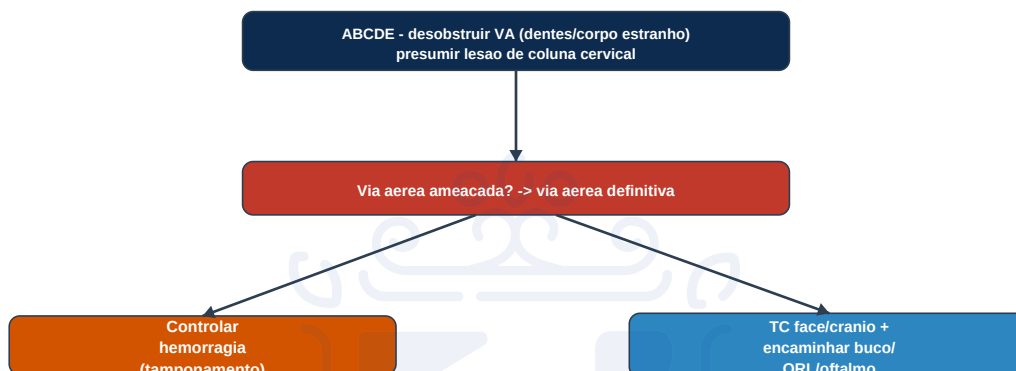


TRAUMA DE FACE — VIA AÉREA E HEMORRAGIA

FLUXOGRAMA — PRIORIDADES

FACE — VIA AÉREA PRIMEIRO, DEPOIS HEMORRAGIA



CARACTERÍSTICAS

O QUE É

- Mecanismos principais: violência interpessoal e queda (acidentes de trânsito hoje menos comuns); homens 20-30 anos
- Frequente associação com: obstrução de via aérea, hemorragia severa, lesão intracraniana e de COLUNA CERVICAL
- TODA vítima de trauma de face de grande impacto = presumir lesão de coluna cervical até excluir por imagem
- Viscerocrânio: osso nasal, maxila, mandíbula, zigomático — o teto da cavidade nasal é assoalho da fossa anterior do crânio

AValiação INICIAL — PRIORIDADES (ABCDE)

VIA AÉREA E HEMORRAGIA

- PRIORIDADE: desobstruir a via aérea (corpos estranhos, ex.: dentes) e garantir permeabilidade (avaliar via aérea definitiva)
- Fratura de terço médio/mandíbula -> risco de obstrução de via aérea (queda da língua sem suporte ósseo)
- Após a ventilação, controlar a hemorragia
- Trauma ocular associado: avaliar acuidade visual, mobilidade ocular e reação pupilar; encaminhar oftalmo
- Líquor pelo nariz/ouvido (rinorreia/otorreia) + sinal de Battle = suspeitar de fratura de base de crânio

TRAUMA NASAL E FRATURA DE BASE

CUIDADO COM O TAMPONAMENTO

- Osso nasal é o que mais fratura na face; epistaxe frequente (área de Kiesselbach, septo anterior)
- ANTES do tamponamento nasal: descartar fratura da lâmina crivosa do etmoide / comunicação com a base do crânio
- Se houver LÍQUOR misturado ao sangue: NÃO tentar parar o sangramento; decúbito lateral para drenar + investigar
- Sem líquido: tamponamento anterior com gaze (pode embeber em fenilefrina/lidocaína); não manter > 24h sem reavaliar
- Persistência -> tamponamento posterior com Foley + encaminhar especialista (referência)

FRATURAS DE TERÇO MÉDIO — LE FORT

Classificação	Características
Le Fort I	Impacto horizontal; separa a maxila das estruturas nasais/zigomáticas (disjunção do palato)
Le Fort II	Forças mais altas; separa a maxila e o complexo nasal da órbita (piramidal)
Le Fort III	Disjunção craniofacial: separa naso-órbita-etmoidal, zigomas e maxila do crânio
Outras	Complexo naso-órbita-etmoidal, zigomático-maxilar, arco zigomático; mandíbula (degraus, má oclusão, parestesia do lábio inferior)

MANEJO DA DOR E MEDIDAS

Rx ANALGESIA ESCALONADA

Dor leve: Dipirona 1g EV 6/6h ou Paracetamol 1g VO 6/6h

Dor moderada: Dipirona 1g EV 6/6h + Tramadol 50mg EV 8/8h

Dor intensa: Dipirona + Tramadol 100mg EV 8/8h; se refratária, Morfina 2-4mg EV lenta (reavaliar em 30-60 min)

EVITAR AINEs se: sangramento ativo, politrauma ou TCE associado

Adjuvantes: compressas frias, cabeça a 30 graus, antiemético (Ondansetrona 4mg EV se náusea)

Mandíbula: dieta líquida/pastosa, higiene com clorexidina 0,12% 3x/dia, analgésico + anti-inflamatório + ATB (amoxicilina); encaminhar buco

CONDUTA E ENCAMINHAMENTO

NÃO ESQUECER

- ☐ ABCDE com proteção cervical; via aérea e hemorragia antes da face em si
- ☐ Avaliar trauma ocular (acuidade/mobilidade/pupila) e sinais de fratura de base
- ☐ TC de face/crânio para diagnóstico definitivo e planejamento; RX panorâmica auxilia na mandíbula
- ☐ Analgesia adequada associada à investigação de lesões associadas (TC face/crânio)
- ☐ Encaminhar a buco-maxilo-facial / ORL / oftalmo conforme a lesão

MODELO DE ENCAMINHAMENTO (SAMU)

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Trauma de face ____ (tipo/Le Fort/nasal/mandíbula) por ____ (mecanismo).
- Via aérea: ____ (pérvia/definitiva); hemorragia controlada: ____ (tamponamento?); líquido: sim/não.
- Trauma ocular associado: ____; sinais de fratura de base: ____; TC face/crânio: ____.
- Solicito transferência para buco-maxilo-facial / ORL e condutas específicas.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com trauma facial grave, sangue e dentes na cavidade oral e estridor. Qual a prioridade?

- A) Tomografia de face imediata
- B) Desobstruir e garantir a via aérea (avaliar via aérea definitiva), com proteção cervical
- C) Tamponamento nasal antes de tudo
- D) Sutura das lacerações
- E) Encaminhamento ambulatorial ao buco

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Antes de realizar tamponamento nasal em trauma de face, o que deve ser descartado?

- A) Fratura de fêmur
- B) Fratura da lâmina crivosa do etmoide / comunicação com a base do crânio (presença de líquido)
- C) Pneumotórax
- D) Fratura de costela
- E) Lesão esplênica

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Toda vítima de trauma de face de grande impacto deve ser considerada como portadora de:

- A) Fratura de pelve
- B) Lesão de coluna cervical até prova radiológica em contrário
- C) Pneumotórax hipertensivo
- D) Lesão hepática
- E) Trauma raquimedular torácico

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

A fratura de terço médio da face com disjunção craniofacial completa (separação do complexo naso-órbito-etmoidal, zigomas e maxila do crânio) é classificada como:

- A) Le Fort I
- B) Le Fort III
- C) Fratura de mandíbula
- D) Fratura de arco zigomático isolada
- E) Le Fort 0

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Quando se deve EVITAR AINE no manejo da dor do trauma de face?

- A) Em qualquer dor leve
- B) Em suspeita de sangramento ativo, politrauma ou TCE associado
- C) Em pacientes jovens
- D) Quando há apenas edema
- E) Nunca há contraindicação

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

No trauma de face, a prioridade é a via aérea: desobstruir (remover dentes/corpos estranhos, sangue) e garantir permeabilidade (avaliar via aérea definitiva), sempre com proteção da coluna cervical. Imagem e sutura vêm depois.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Antes do tamponamento nasal, deve-se descartar fratura da lâmina crivosa do etmoide/comunicação com a base do crânio (risco de passagem intracraniana). Havendo líquido com o sangue, não se tenta conter o sangramento.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Toda vítima de trauma de face de grande impacto deve ser tratada como tendo lesão de coluna cervical até que exames radiológicos a excluam — daí a imobilização cervical de rotina.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A Le Fort III é a disjunção craniofacial completa, separando o complexo naso-órbito-etmoidal, os zigomas e a maxila do crânio. Le Fort I é horizontal (palato); Le Fort II é piramidal.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Evita-se AINE quando há suspeita de sangramento ativo, politrauma ou TCE associado (risco hemorrágico). Nesses casos prefere-se dipirona/paracetamol e opioides conforme a intensidade.

SM24
Suporte ao Plantão Médico